

EPREUVE DE RATRAPAGE

1) Dans les occlusions grêliques, les niveaux hydro-aériques sont : Les RJ

- A/ Centraux ✓
- B/ Plus larges que hauts. ✓
- C/ Plus hauts que larges. ✓
- D/ Souvent nombreux. ✓
- E/ Peu nombreux.

2) La strangulation dans les occlusions intestinales survient par : (Les RJ)

- A. Une bride. ✓
- B. Un volvulus.
- C. Une tumeur.
- D. Un corps étranger intra-luminal.
- E. Une invagination intestinale. ✓

3) Toutes ces complications peuvent se voir en cas d'appendicite aiguë négligée ; sauf une : laquelle ?

- A. Péritonite aiguë.
- B. Abscès intra-abdominal.
- C. Sepsis.
- D. Choc septique.
- E. Occlusion sur bride ✓

4) Les signes suivants sont en faveur d'une péritonite aigue appendiculaire sauf un, lequel ?

- A. Fièvre à 39°C d'emblée
- B. Défense abdominale
- C. Maximum des douleurs au niveau de la fosse iliaque droite ✓
- D. Absence de cicatrice Mac Burney
- E. Présence d'un pneumopéritoine à l'ASP

5) L'examen de référence pour le diagnostic radiologique de l'appendicite aigue est : réponse ju

- A. L'abdomen debout sans préparation ✓
- B. L'échographie abdomino-pelvienne
- C. Le scanner abdominal
- D. L'IRM abdominale ✓
- E. Transit baryté du colon ✓

6) En cas de péritonite appendiculaire, il est classique d'observer :
A. une douleur abdominale d'apparition brutale ✓
B. une contracture abdominale prédominante en fosse iliaque droite ✓
C. une douleur au toucher rectal localisée dans le cul-de-sac de Douglas ✓
D. un pneumopéritoine sur l'ASP
E. un syndrome septique souvent sévère

7) Parmi les propositions suivantes concernant les signes cliniques de l'appendicite aiguë, laquelle est EXACTE ?
A. La fièvre est toujours supérieure à 39°C ✓
B. Les vomissements sont un signe constant et précoce ✓
C. La contracture abdominale est un signe présent dans toutes les formes
D. Un tableau de péritonite généralisée peut survenir d'emblée
E. Aucune des réponses précédentes n'est exacte

8) Toutes les affirmations suivantes concernant les diverticules coliques sont fausses sauf une. Laquelle ?
A. Les diverticules coliques sont plus fréquents au niveau du colon droit
B. Les diverticules coliques sont l'apanage des sujets Agés ✓
C. Une alimentation riche en fibres contribue à leur formation ✓
D. seules les diverticules du colon droit peuvent dégénérer
E. La complication aigue la plus fréquente est l'hémorragie diverticulaire

9) La diverticulose colique : réponse juste

- A. Touche exclusivement le colon gauche
- B. Est due à une alimentation riche en fibres ✓
- C. Favorise la survenue du cancer colique
- D. L'utilisation des antibiotiques n'est pas systématique en cas de diverticulite
- E. LA TDM est l'examen de référence en cas de diverticulite aigue

10) La diverticulose sigmoïdienne compliquée, combinaison juste :

- A. Une pneumaturie peut-être un motif révélateur
- B. La coloscopie l'examen clé pour faire le diagnostic
- C. Peut-être à l'origine d'une hémorragie digestive basse
- D. L'examen clinique est souvent normal
- E. Peut-être révélée par un arrêt des matières et des gaz

A : 1,2,3

B : 1,3,4

C : 1,3,5

D : 2,3,5

E : 3,4,5

11) Le kyste hydatique stade IV selon la classification de Gharbi pose un problème de diagnostic différentiel avec : réponse juste

- A. Kyste biliaire
- B. Tumeur hépatique ✓
- C. Hématome
- D. Lithiase intrahépatique
- E. Nodule de régénération sur foie de cirrhose

12) L'hydatidose hépatique : réponse fausse

- A. Est une pathologie des mains sales ✓
- B. La sérologie hydatique négative n'élimine pas le diagnostic ✓
- C. A l'échographie un aspect de lésion focale solide correspond à type IV de Gharbi ✓
- D. La rupture dans le péritoine peut-être à l'origine d'une hydatidose maligne ✓
- E. Le traitement chirurgical est réservé aux formes compliquées ✓

13) Dans la Cholécystite aiguë de gravité modérée (grade 2 Tokyo GL 2018) : (La RJ)

- A. Elévation des globules blancs ($> 18\ 000/\text{mm}^3$),
- B. Masse palpable dans l'hypochondre droit,
- C. Durée des signes clinique de plus de 72 h,
- D. Péritonite biliaire localisée, abcès périvésiculaire.
- E. Toutes ces réponses sont justes.

14) La hernie hiatale est définie par : RJ

- A. La protrusion de l'estomac à travers la paroi abdominale antérieure
- B. Le passage d'organes abdominaux à travers l'orifice œsophagien du diaphragme
- C. La hernie exclusive du fundus gastrique
- D. Une anomalie congénitale toujours symptomatique
- E. Une pathologie strictement chirurgicale

15) Le carcinome épidermoïde est : réponse juste

- A. A différenciation glandulaire
- B. Peut se voir sur toute la hauteur de l'œsophage
- C. Est rare au niveau de l'œsophage
- D. Une prolifération mésenchymateuse
- E. Se développe sur une métaplasie intestinale

16) L'adénocarcinome de l'œsophage : réponse juste

- A. Est une tumeur bénigne ✓
- B. Est d'architecture fusocellulaire
- C. Se développe sur métaplasie malpighienne
- D. Est de type intestinal le plus souvent
- E. Est le plus souvent situé au niveau du tiers supérieur de l'œsophage

17) Tous ces aspects endoscopiques sont habituellement retrouvés au cours de la rectocolite hémorragique sauf un ? (La RF)

- A. Atteinte continue sans espaces de muqueuse saine
- B. Muqueuse congestive et érosive (aspect granité)
- C. Ulcérations aphtoïdes
- D. Atteinte rectale constante
- E. Les lésions sont ascendantes

18) La maladie de Crohn : (La RF)

- A. Est une atteinte transmurale
- B. Les lésions endoscopiques sont diffuses à tout le colon
- C. L'atteinte ano-périnéale peut précéder l'atteinte intestinale
- D. Peut-être associée à des atteintes extra-digestives articulaires et ophtalmiques
- E. La chirurgie est réservée aux formes compliquées et doit être conservatrice

les manifestations cliniques apparaissent :

19) A propos du syndrome d'hypertension portale, les manifestations cliniques apparaissent généralement lorsque le gradient portosystémique dépasse (choisissez la réponse juste) :

- A. 5 mmHg
- B. 8 mmHg
- ☒ C. 12 mmHg
- D. 15 mmHg
- E. 35 mmHg

20) Au cours du syndrome d'HTP, la splénomégalie (choisissez les réponses justes) :

- A. Son volume est corrélé au degré d'HTP.
- B. Est toujours douloureuse.
- ☒ C. Peut manquer
- ☒ D. Peut être responsable de thrombopénie.
- E. Toutes les réponses sont justes.

21) A partir de quelle quantité, l'ascite devient détectable cliniquement ? réponse juste

- A. 2,5 litres
- ☒ B. 1,5 litres
- C. 3 litres
- D. 4 litres
- E. Aucune proposition

22) Quels sont Les principaux facteurs qui peuvent déterminer une hépatite fulminante : (Cocher l'association juste)

- 1. Un syndrome de cytolyse avec ALAT et ASAT supérieur à 10 fois la normale
- 2. Un syndrome de cholestase ictérique
- ☒ 3. Un TP inférieur à 50 %
- 4. Un TP inférieur à 70 %
- ☒ 5. Une encéphalopathie hépatique

A (1+3) B (1+4) ☒ C (3+5) D (1+5) E (4+5)

23) Quelle complication est la plus typique de l'œsophagite peptique sévère ? réponse juste

- A. Dysphonie.
- ☒ B. Sténose œsophagienne.
- C. Fistule œso-bronchique.
- D. Diverticule œsophagien.
- E. Pneumomédiastin spontané.

24) Le calcul cholestérique est du (RF) :

- ☒ A. Augmentation de la motricité de la vésicule biliaire
- B. Favorisé par les grossesses, obésité
- C. Sursaturation de la bile en cholestérol,
- D. Phénomènes de cristallisation du cholestérol
- E. Favorisé par l'insulino-résistance et l'amaigrissement rapide.

25) Parmi les signes cliniques suivants, quel est le seul permettant au cours d'une cholécystite aiguë de suspecter une lithiase de la voie biliaire principale ?

- A. Grosse vésicule
- B. Fièvre
- ☒ C. Ictère
- D. Douleur provoquée de l'hypochondre droit
- E. Aucune réponse n'est juste

26) Patient âgée de 50 ans, consulte pour des coliques hépatiques. Une échographie abdominale a été faite révélant une microlithiase vésiculaire avec une voie biliaire principale fine contenant deux microlithiases de 3 et 5 millimètres. Quel sera votre attitude thérapeutique ? Réponse juste

- A. Sphinctérotomie endoscopique suivie d'une cholécystectomie par voie coelioscopique.
- B. Sphinctérotomie endoscopique seule.
- C. Sphinctérotomie endoscopique et une désobstruction de la VBP par DI
- D. Cholécystectomie seule.
- E. Cholécystectomie par laparoscopie suivie d'une sphinctérotomie laparotomie.

27) Dans les ulcères hémorragiques de la face postérieure du premier duodénum, le vaisseau le plus souvent responsable du saignement est :

- A. Artère hépatique moyenne
- B. Artère pylorique
- ☒ C. Artère gastroduodénale
- D. Artère pancréatico-duodénale inférieure
- E. Aucune artère des artères citées

28) Une hernie hiatale par glissement (type I) correspond à : réponse juste

- A. Une ascension isolée du fundus gastrique
- ☒ B. Une ascension du cardia au-dessus du diaphragme
- C. Une rotation de l'estomac dans l'abdomen
- D. Un déplacement du côlon transverse dans le thorax
- E. Une malposition du foie

29) Quel symptôme est le plus fréquemment rapporté dans les hernies hiatales par glissement

- ☒ A. Reflux gastro-œsophagien
- B. Ictère
- C. Hémoptysie
- D. Rectorragie
- E. Constipation

30) La péritonite aiguë par perforation d'ulcère : (La RF)

- A. Complique plus souvent l'ulcère de la face antérieure du bulbe
- ☒ B. La fièvre est un signe précoce ✓
- C. Une défense ou contracture abdominale sont fréquemment retrouvées à l'examen clinique
- D. Des niveaux hydro-aériques peuvent être retrouvés à l'ASP
- E. Le toucher rectal est douloureux ✓

- 31) Chez un patient atteint de tuberculose intestinale, quel est le mécanisme de contamination le plus fréquent ? (La RJ)
- A. Ingestion d'eau contaminée par *Mycobacterium bovis*.
 - ☒ B. Dissemination hématogène à partir d'un foyer pulmonaire primaire ou réactivé.
 - C. Transmission oro-fécale directe d'un sujet contagieux.
 - D. Propagation par contiguïté depuis une tuberculose génitale.
 - E. Inhalation de particules en aérosol contaminées.

- 32) L'ingestion d'un produit caustique de type esprit de sels (acide chlorhydrique) : réponse fausse
- A. Les lésions sont classiquement plus sévères au niveau de l'ante gastrique
 - B. Entraîne une nécrose de liquéfaction
 - C. La mise en place d'une sonde nasogastrique est contre indiquée
 - D. L'avis du psychiatre est obligatoire en cas de tentative d'autolyse quelque soit la gravité
 - E. La TDM permet une meilleure évaluation des lésions que l'endoscopie

- 33) L'étranglement herniaire : (La RF)

- A. Est irréductible
- B. La douleur reste le symptôme majeur dans ce cas
- ☒ C. L'échographie abdominale est l'examen de première intention
- D. Peut s'accompagner d'une nécrose intestinale
- E. Une prise en charge tardive peut mettre en jeu le pronostic vital

- 34) La maladie coeliaque de l'adulte est caractérisée par : réponse fausse
- A. Une positivité des anticorps anti-transglutaminase de type IgA est fréquemment retrouvée
 - B. Peut être révélée par une anémie ferriprive isolée
 - C. L'atrophie villositaire totale à subtotale à l'histologie n'est pas constante
 - D. Le traitement repose sur un régime sans gluten à vie
 - E. La positivité HLA DQ2 ou DQ8 affirme le diagnostic

- 35) Parmi ces lésions précancéreuses de la vésicule biliaire et des voies biliaires extra-hépatiques, une seule n'a aucune traduction macroscopique laquelle ?

- A. Adénome,
- ☒ B. Néoplasie biliaire intra-épithéliale (BILIN),
- C. Néoplasie papillaire intra cholécystique,
- D. Néoplasie kystique mucineuse avec néoplasie intra-épithéliale,
- E. Néoplasie papillaire intracanalalaire.

- 36) Concernant la maladie de Crohn, quelle est la proposition juste ?

- A. L'atteinte est limitée au côlon et au rectum exclusivement.
- ☒ B. Les lésions muqueuses sont continues sans intervalle de muqueuse saine.
- C. La présence de granulomes épithélioïdes géantocellulaires sans nécrose caséuse est un critère histologique évocateur.
- D. L'inflammation est superficielle, limitée à la muqueuse.
- E. Les fistules et sténoses sont absentes dans la maladie de Crohn.

- 37) Concernant l'adénocarcinome colorectal, quelle est la proposition juste ?
- A. Un adénocarcinome représente moins de 50 % des cancers colorectaux.
 - B. Les embolies tumorales et engraments périnerveux sont des facteurs histopronostiques.
 - C. Le carcinome muqueux est de bon pronostic.
 - D. La classification pTNM utilisée est celle de l'OMS 2010.
 - E.
- 38) Parmi ces types histologiques du cancer du pancréas quel est celui qui est le plus fréquent (RJ) :
- A. Carcinome à cellules acineuses
 - B. Adénocarcinome canalaire
 - C. Cystadénocarcinome séreux
 - D. Cystadénocarcinome muqueux
 - E. Tumeur pseudopapillaire et solide
- 39) Une tumeur neuroendocrine du pancréas bien différenciée avec un index mitotique à 28 mitoses/10 HPF et un Ki67 à 25% est gradée :
- A. Tumeur neuroendocrine (TNE) G2
 - B. Tumeur neuroendocrine (TNE) G3
 - C. Carcinome neuroendocrine à petites cellules
 - D. Carcinome neuroendocrine à grandes cellules
 - E. Tumeur neuroendocrine (TNE) G1
- 40) Le carcinome hépatocellulaire se présente sous toutes ces formes sauf une, laquelle :
- A. La forme expansive
 - B. La forme micronodulaire
 - C. La forme infiltrante
 - D. La forme mixte
 - E. La forme diffuse